

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

SCL-90-R · CUESTIONARIO DE 90 SÍNTOMAS REVISADO

Symptom Checklist-90-Revised – Medida estándar multidimensional de distrés psicológico, espectro psicopatológico e índices globales de gravedad

1. Identificación General del Instrumento

Nombre oficial	Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90-R)
Nombre en español	Cuestionario de 90 Síntomas Revisado
Sigla oficial	SCL-90-R
Autores originales	Leonard R. Derogatis (1977, 1994)
Adaptación hispanohablante	José Luis González de Rivera et al. (1989, 2002); TEA Ediciones / Pearson
Año de publicación original	1977 (versión revisada SCL-90-R; baremos españoles en 2002)
Constructo primario	Distrés psicopatológico global, sintomatología psiquiátrica actual y malestar subjetivo
Formato de administración	Autoinforme estructurado con escala Likert de 5 puntos (0 = Nada a 4 = Mucho/Extremadamente)
Población diana	Población clínica y comunitaria adolescente y adulta (≥ 13 años)
Tiempo de aplicación	12 a 15 minutos (90 ítems referidos a los últimos 7 días)
Régimen de acceso	Instrumento psicométrico comercial distribuido bajo licencia (Pearson / TEA Ediciones)

2. Fundamentación Conceptual y Marco Clínico

El **Cuestionario de 90 Síntomas Revisado** (SCL-90-R) es uno de los instrumentos psicométricos más ampliamente utilizados en psiquiatría, psicología clínica y medicina conductual en todo el mundo. Creado por Leonard R. Derogatis en el marco del Clinical Psychometrics Research Program del Johns Hopkins University, el SCL-90-R fue concebido para capturar el perfil multidimensional de malestar somático y psicológico experimentado por el sujeto durante la última semana.

El cuestionario estructura la experiencia psicopatológica en nueve dimensiones sintomáticas primarias (Somatización, Obsesión-Compulsión, Sensibilidad Interpersonal, Depresión, Ansiedad, Hostilidad, Ansiedad Fóbica, Paranoïdismo y Psicoticismo) y complementa el análisis con tres índices globales de distrés que resumen la carga mórbida total: el **Índice de Severidad Global (GSI)**, indicador más sensible de intensidad patológica; el **Total de Síntomas Positivos (PST)**, que refleja la extensión sintomática; y el **Índice de Malestar de Síntomas Positivos (PSDI)**, que mide la intensidad media por síntoma positivo. La adaptación española de González de Rivera (TEA Ediciones) proporcionó baremos robustos diferenciados por sexo y población (clínica vs. general), transformando las puntuaciones directas a puntuaciones T normativas.

3. Dominios Evaluados y Composición de Ítems

Dimensión Sintomática	N.º Ítems	Rango	Contenido Clínico y Manifestaciones Evaluadas
1. Somatización (SOM)	12 ítems	0 – 48	Malestar derivado de percepciones corporales (cardiovascular, gastrointestinal, dolores musculares).
2. Obsesión-Compulsión (OBS)	10 ítems	0 – 40	Pensamientos intrusivos, impulsos indeseados y conductas repetitivas o dudas continuas.
3. Sensibilidad Interpersonal (SI)	9 ítems	0 – 36	Sentimientos de timidez, inferioridad, inadecuación e hipersensibilidad ante las opiniones ajenas.
4. Depresión (DEP)	13 ítems	0 – 52	Tristeza, anhedonia, pérdida de energía vital, desesperanza e ideación autolítica.
5. Ansiedad (ANS)	10 ítems	0 – 40	Tensión motora, nerviosismo, pánico, palpitaciones y aprensión cognitiva.
6. Hostilidad (HOS)	6 ítems	0 – 24	Pensamientos de ira, agresividad, resentimiento e irritabilidad descontrolada.
7. Ansiedad Fóbica (FOB)	7 ítems	0 – 28	Miedo irracional a espacios abiertos, multitudes, transporte público y lugares cerrados.
8. Paranoïdismo (PAR)	6 ítems	0 – 24	Pensamiento suspicaz, desconfianza, miedo a la pérdida de autonomía y suspicacia.
9. Psicoticismo (PSI)	10 ítems	0 – 40	Aislamiento extremo, vivencias de extrañeza, alucinaciones y control del pensamiento.
Ítems Adicionales / Misceláneos	7 ítems	0 – 28	Ítems 19, 44, 59, 60, 64, 73, 89 (alteraciones del apetito, sueño, culpa existencial).
Índices Globales (GSI, PST, PSDI)	90 ítems	0 – 360	GSI = Suma total / 90. PST = N.º ítems > 0. PSDI = Suma total / PST.

4. Validez, Confiabilidad y Rendimiento Diagnóstico en España / LatAm

Propiedad Métrica	Coficiente / Hallazgo	Contexto Empírico y Validación Hispana
Consistencia interna global (GSI)	Alpha de Cronbach = 0.96 – 0.98	Sobresaliente consistencia interna en la validación española de González de Rivera (2002).
Consistencia interna dimensiones	Alpha = 0.77 – 0.90	DEP (0.90), SOM (0.87), ANS (0.86), OBS (0.84), SI (0.83), PSI (0.77). Elevada fiabilidad factorial.
Fiabilidad test-retest	r = 0.78 – 0.90 (1 semana)	Gran estabilidad temporal en ausencia de intervención clínica o farmacológica aguda.
Validez convergente	r = 0.73 con BDI; r = 0.71 con STAI-E	Alta correlación con escalas de depresión de Beck y de ansiedad estado de Spielberger.
Capacidad discriminante (Caseness)	Sensibilidad 83%, Esp 82%	Diferenciación nítida entre pacientes psiquiátricos, somatizadores ambulatorios y población general.

5. Reglas de Corrección y Cómputo de Puntuaciones

- **Gradación Likert de 5 puntos:** 0 = Nada; 1 = Muy poco; 2 = Poco; 3 = Bastante; 4 = Mucho / Extremadamente.
- **Puntuaciones directas dimensionales:** Suma de las respuestas a los ítems que componen cada una de las 9 dimensiones dividida por el número de ítems de dicha dimensión (rango de medias dimensionales: 0.00 a 4.00).
- **Cómputo de los Tres Índices Globales:**
 - **GSI (Global Severity Index):** Suma total de los 90 ítems dividida entre 90 (o entre el número total de ítems contestados). Es el mejor indicador individual de la intensidad actual del sufrimiento psicológico.
 - **PST (Positive Symptom Total):** Recuento simple del número total de ítems puntuados con valor ≥ 1 (rango: 0 a 90). Refleja la amplitud o polimorfismo del cuadro sintomático.
 - **PSDI (Positive Symptom Distress Index):** Suma total de las respuestas dividida entre el PST. Informa sobre si el paciente tiende a amplificar o minimizar los síntomas que reconoce.
- **Conversión a Puntuaciones T:** Se trasladan los valores a la escala T (media = 50, DE = 10) utilizando los baremos españoles según sexo y tipo de muestra (clínica o no clínica).

6. Baremos Normativos, Puntos de Corte y Estratificación Clínica

Puntuación T (GSI)	Categoría Clínica	Significación Psicopatológica e Indicación Terapéutica
T < 55 (Percentil < 70)	Rango No Clínico / Normal	Nivel de distrés psicológico dentro de los parámetros de adaptación normal. Ausencia de patología psiquiátrica significativa.
T 55 – 62 (Percentil 70 – 89)	Riesgo Subclínico / Leve	Presencia de reactividad emocional o estrés situacional. Requiere seguimiento ambulatorio o apoyo preventivo.
T ≥ 63 (Percentil ≥ 90)	Caso Clínico / “Caseness”	Punto de corte estandarizado de Derogatis. Indica malestar psiquiátrico significativo. Requiere evaluación clínica diagnóstica formal e intervención.
T ≥ 70 (Percentil ≥ 98)	Gravedad Psicopatológica Severa	Malestar psíquico masivo, disfunción global severa y elevado sufrimiento. Requiere tratamiento psiquiátrico y psicológico intensivo.

CRITERIO OPERATIVO DE RIESGO CLÍNICO (“CASE”): Derogatis (1994) Se considera a un sujeto como **caso clínico positivo** si cumple cualquiera de las dos condiciones siguientes: 1) **GSI con T ≥ 63** ; o 2) **Dos o más dimensiones sintomáticas primarias con T ≥ 63** .

7. Algoritmo de Decisión Clínica e Intervención Asistencial

Paso 1: Cribado general y cálculo de índices globales:

- Administrar el SCL-90-R como cribado multidimensional de entrada en salud mental o ante sospecha de somatización médica no filiada.
- Comprobar validez del protocolo: PST < 10 con GSI muy bajo sugiere minimización/fingimiento de normalidad; PSDI > 3.5 con GSI elevado sugiere amplificación/sobrediálogo de quejas.

Paso 2: Análisis del perfil dimensional:

- **Elevación aislada en SOM:** Descartar patología médica oculta; derivación a protocolo de somatización y desensibilización interoceptiva.
- **Elevación concomitante en DEP y ANS:** Patrón ansioso-depresivo mixto de alta frecuencia. Iniciar TCC e ISRS.
- **Elevación en PAR y PSI (T ≥ 65):** Realizar exploración psicopatológica pormenorizada de vivencias delirantes o alucinaciones.

Paso 3: Monitorización de la eficacia terapéutica:

- Reaplicar a los 3 y 6 meses de tratamiento. Una reducción del GSI > 0.30 puntos (o > 5 puntos T) representa una respuesta terapéutica clínicamente significativa.

8. Caso Clínico Ilustrativo

Identificación: Mujer de 38 años, docente de secundaria, derivada desde Medicina Interna tras múltiples estudios negativos por cefaleas tensionales, disfgia, parestesias erráticas e insomnio global de 6 meses de evolución.

Resultados en SCL-90-R (Baremos Mujeres Población General):

- **GSI = 1.45 (Puntuación T = 66) -> Criterio de Caso Clínico cumplido.**
- PST = 54 ítems positivos; PSDI = 2.42 (perfil de respuesta congruente).
- **Perfil Dimensional Destacado:**
 - ▶ Somatización (SOM): Media = 2.15 (T = 72) -> Elevación muy severa.
 - ▶ Ansiedad (ANS): Media = 1.80 (T = 65) -> Rango clínico positivo.
 - ▶ Depresión (DEP): Media = 1.55 (T = 63) -> Umbral clínico positivo.
 - ▶ Resto de dimensiones (OBS, SI, HOS, FOB, PAR, PSI): Puntuaciones T entre 48 y 56 (normales).

Diagnóstico y Evolución Terapéutica: El perfil del SCL-90-R demostró con nitidez un Trastorno de Síntomas Somáticos con comorbilidad ansioso-depresiva reactiva a sobrecarga laboral (**burnout**). La visualización gráfica del perfil ayudó a la paciente a comprender el origen emocional de sus somatizaciones. Se inició psicoterapia cognitivo-conductual centrada en reatribución somática y técnicas de relajación, junto a Duloxetina 60 mg/día. A los 4 meses, el GSI descendió a 0.72 (T = 52), con remisión casi completa de la clínica somatomorfa.

9. Alertas de Seguridad y Diagnóstico Diferencial

ALERTAS DE SEGURIDAD CRÍTICA:

- **Ítem 15 (Pensamientos de suicidio):** Toda puntuación ≥ 1 en el ítem 15 requiere exploración inmediata de intencionalidad autolítica activa.
- **Estilo de respuesta disimulador:** Un PST < 3 con GSI < 0.10 en pacientes derivados por vía forense indica probable ocultamiento consciente de síntomas.
- **Crisis psicótica aguda:** Puntuaciones elevadas en PSI no equivalen de forma automática a esquizofrenia; pueden reflejar despersonalización en crisis de angustia o trauma.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:

- **SCL-90-R vs. BDI / BAI:** El SCL-90-R es un mapa general de cribado de amplio espectro; no sustituye a las medidas monográficas específicas de severidad.
- **Patología médica no diagnosticada:** En pacientes ancianos con SOM muy elevada, descartar siempre tiroidopatías, patología autoinmune o neoplasias.
- **Trastorno por Ansiedad a la Enfermedad:** Distinguir entre quejas corporales múltiples (SOM) y convicción hipocondríaca obsesiva de padecer una enfermedad letal.

10. Referencias Bibliográficas Científicas

1. Derogatis, L. R. (1977). **SCL-90-R: Administration, scoring and procedures manual-I for the R(evised) version**. Baltimore: Clinical Psychometrics Research Unit, Johns Hopkins University School of Medicine.
2. González de Rivera, J. L., de las Cuevas, C., Rodríguez-Abuín, M., & Rodríguez-Pulido, F. (2002). **Cuestionario de 90 Síntomas SCL-90-R: Manual**. Madrid: TEA Ediciones.
3. Derogatis, L. R., & Savitz, K. L. (2000). The SCL-90-R and the Brief Symptom Inventory (BSI) in primary care. In M. E. Maruish (Ed.), **Handbook of psychological assessment in primary care settings** (pp. 297–334). Lawrence Erlbaum Associates.
4. Caparrós-Caparrós, B., Villar-Hoz, E., Juan-Ferrer, J., & Viñas-Poch, F. (2007). Symptom Check-List-90-R: fiabilidad y validez en una muestra de población universitaria. **Papeles del Psicólogo**, 28(3), 205–210.